

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS A ANEMIA
EN GESTANTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL EL
PORVENIR, LA VICTORIA – LIMA, PERIODO DEL 2023**

PROYECTO DE TESIS

PRESENTADO POR:

SIGUAS GODOY, SANDRA ELIZABETH

LIMA - PERU

2024

LINEA DE INVESTIGACION
SALUD PUBLICA

AGRADECIMIENTO

A Dios que guía mis pasos, a mi familia que siempre me ha dado la fortaleza y el refugio en las adversidades, gracias por ser ese apoyo constante en este largo camino.

DEDICATORIA

A mi madre, a mi esposo y a mi hija,
quienes son los pilares de mi vida

INDICE

CARATULA	I
LINEA DE INVESTIGACION	II
AGRADECIMIENTO	III
DEDICATORA	IV
INDICE	V
INTRODUCCION	VII
LISTA DE ANEXOS	VIII

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Formulación del problema	2
1.2.1. Problema general	2
1.2.2. Problema específico	2
1.3. Justificación	2
1.4. Delimitación del área de estudio	3
1.5. Objetivos	3
1.5.1. Objetivo general	3
1.5.2. Objetivos específicos	3

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación	6
2.2. Bases teóricas	9
2.3. Definición de conceptos operacionales	12

CAPITULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES

3.1	Hipótesis	13
3.1.1.	Hipótesis General	13
3.1.2.	Hipótesis Específicas	13
3.2.	Variables de Estudio	13
3.3.	Operacionalización de variables	13
CAPITULO IV METODOLOGIA		14
4.1.	Diseño Metodológico	14
4.1.1.	Tipo de Investigación	14
4.1.2.	Nivel de Investigación	14
4.2.	Población y Muestra	14
4.3.	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	15
4.4.	Técnica de Procesamiento y Análisis de datos	15
4.5.	Consideraciones Éticas	15
CAPITULO V: ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION		17
5.1	Presupuesto	17
5.2	Cronograma de actividades	17
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS		21
ANEXOS		

INTRODUCCION

La anemia gestacional es una patologia comun a nivel mundial, los países subdesarrollados o del tercer mundo son los que presentan las mas altas prevalencias, lo cual se considera un problema de salud publica, es por ello la importancia de conocer la fisiopatologia, el cuadro clinico, el tratamiento y los métodos de diagnostico y prevencion de la anemia.

Esta enfermedad al ser multifactorial, necesita del trabajo conjunto de todos los estamentos del estado, asi como el compromiso de todo el personal de salud para ayudar a reducir la tasa de anemia sobre todo en la poblacion gestante, ya que si protegemos a la madre, estamos salvaguardando la salud y vida del nuevo ser que se encuentra en crecimiento.

Los efectos adversos que trae consigo una anemia no tratada repercuten doblemente en la madre y en el recién nacido, es sabido que dentro de las complicaciones maternas se encuentran los partos pretermino, ruptura prematura de membranas, y las complicaciones fetales pueden ser bajo peso al nacer y con ello perpetuarse en el recién nacido los efectos de una anemia no tratada.

Este estudio pretende dar a conocer los factores socioeconomicos, ginecoobstetricos y nutricionales que pueden influir en la anemia gestacional en el CMI El Porvenir durante el 2023, con el fin de contribuir con conocimientos actualizados sobre la prevalencia de anemia en Lima.

CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La anemia es un trastorno en el que la hemoglobina se encuentra en valores por debajo de 11 gr/d.

Anemia gestacional: la OMS cataloga como anemia en el 1er y 3er trimestre a un dosaje de hemoglobina inferior a 11 gr/dl, y en el 2do trimestre a valores por debajo de 10 g/dl¹.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que del total de la población mundial el 20% padece anemia ferropénica. Según estudios sobre la incidencia de la enfermedad realizados en muchos lugares del mundo, en África, la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas es 57,1%, Asia 48,2%, Mediterráneo Oriental 44,2%, Europa 25% y América 24.1%¹.

Varios estudios han recopilado estadísticas sobre la anemia durante el tercer trimestre del embarazo, mostrando altas tasas de anemia en afroamericanos (48,5%) y personas de ascendencia afroamericana (48,5%), hispanos y latinos (30,1%); asiáticos, nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, 29%; mientras que esto sólo se aplica al 27,5% de las mujeres europeas².

En Cuba las gestantes con anemia son de aproximadamente el 35% en los últimos 3 meses del embarazo, menos del 4% presenta anemia grave y el 66,5% presenta anemia leve².

En Perú, las gestantes con anemia en el 2023 fueron de aproximadamente el 38%. La prevalencia disminuyó 0,6 puntos porcentuales respecto a 2022 por región geográfica: 45,5% y 42,8% en Huancavelica y Puno, respectivamente³.

Factores personales como la edad, la paridad, el nivel educativo y el componente social están asociados con la aparición de anemia en mujeres embarazadas.

Sabemos que la deficiencia de hierro afecta la calidad de vida y las actividades del paciente, además de las consecuencias para el feto; por eso, es importante brindar a las mujeres un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado en esta etapa de la vida⁴.

Este estudio busca evaluar los factores individuales relacionados a anemia en gestantes del Centro Materno Infantil El Porvenir situado en el distrito de la Victoria durante el periodo del 2023, para así contribuir con información actualizada para ayudar a tomar medidas para ayudar a disminuir las tasas de anemia en las gestantes.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son los factores individuales relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir, periodo del 2023?

1.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO

PE1: ¿Cuál es el factor sociodemográfico relacionado a anemia en gestantes del CMI El Porvenir en el periodo del 2023?

PE2: ¿Cuál es el factor obstétrico relacionado a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir en el periodo del 2023?

PE3: ¿Cuál es el factor nutricional relacionado a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir en el periodo del 2023?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Justificación teórica

La presente investigación permite revisar aspectos teóricos de las diversas bibliografías sobre los factores individuales relacionados anemia gestacional con el fin de reafirmar los conocimientos sobre esta enfermedad.

Justificación practica

Es importante la adecuada identificación de la anemia gestacional, ya que se puede abordar oportunamente y tratar esta dolencia a fin de evitar las consecuencias posteriores y evitar la morbilidad materno perinatal.

Justificación social

El estudio busca establecer soluciones para la disminución de la anemia gestacional y así disminuir la anemia en este grupo poblacional.

Justificación Metodológica

El estudio utilizará como herramienta un formulario para recolectar información relevante de las pacientes, validado para factores individuales que intervienen en la anemia en mujeres embarazadas, el cual será extraído de la historia clínica la cual se encuentra almacenada en el servicio de archivo del CMI El Porvenir.

1.4 Delimitación del área de estudio

El proyecto de investigación se realizará en el CMI El Porvenir, situado en el distrito de la Victoria durante el periodo del 2023, se buscará establecer las variables asociadas a anemia en las mujeres embarazadas que acuden al servicio de ginecoobstetricia.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores individuales relacionados a la anemia en gestantes del Centro Materno Infantil El Porvenir- La victoria durante el periodo del 2023

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Establecer la relación de los factores sociodemográficos en la anemia de las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023.

OE2: Identificar la relación de los factores ginecoobstétricos en la anemia de las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023.

OE3: Describir la relación de los factores nutricionales en la anemia de las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Hierrezuelo-Rojas N, Johnson-Valenciano S, Hernández-Magdariaga A, en su estudio del 2023 titulado Factores predictivos de anemia en gestantes de un área de salud

Su objetivo fue identificar factores que predicen la aparición de anemia en mujeres embarazadas atendidas en el Policlínico Ramón López Peña. El estudio incluyó a 204 mujeres embarazadas reclutadas en 2022, siendo la mitad los casos y el resto los controles, el muestreo que se utilizó fue el aleatorio simple. La anemia del embarazo se consideró la variable dependiente. La anemia se define como una concentración de hemoglobina inferior a 11,0 g/l en cualquier trimestre del embarazo. Las variables independientes fueron: la edad, grado de estudio, situación familiar, ingresos económicos, relación laboral, bajo peso corporal, antecedentes de anemia, embarazo múltiple, embarazo múltiple, período entre gestaciones corto, y comorbilidades asociadas a la gestación. El intervalo de confianza (IC) del odds ratio (OR) se encuentra en el nivel de confianza del 95%. Como resultado, se encontró que el 52,9% de las pacientes presentó anemia leve y el 44.1% fue en el tercer trimestre de embarazo ⁵.

Garbay Y, Batista Y, Alvarez J, en su estudio del 2023 sobre Factores de riesgo de la anemia durante el embarazo

El estudio fue de tipo observacional, analítico y retrospectivo de casos y controles. La muestra fue de 114 mujeres embarazadas y se utilizó el muestreo aleatorio simple. Se excluyeron del estudio las mujeres embarazadas con hemoglobinopatías y aquellas sin expediente médico. Criterios de selección de

casos: Se consideró como variable dependiente a la anemia y los factores sociodemográficos (edad, nivel socioeconómico), hábitos tóxicos (fumar, tomar café y té), factores nutricionales (IMC basal, HB), hábitos alimentarios y factores obstétricos como variable independiente. El resultado fue que el 31,9% de las mujeres embarazadas tienen riesgo a padecer de anemia. Los malos hábitos alimentarios aumentan 7 veces el riesgo de anemia. El bajo nivel inicial de hemoglobina tuvo un OR de 10.1 y los malos hábitos alimentarios representan un OR de 3,5. Se reconoce que la anemia en el embarazo es multifactorial y proporcional al número de factores de riesgo, de ahí la importancia de la intervención temprana para reducir la incidencia de anemia durante el embarazo⁶.

Lardito F, Maldonado A, Marcenal Y, et al en su estudio “Anemia y embarazo en el Centro Hospitalario Pereira Rossell 2021, en el 2022 realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo, tuvo como objetivo explicar la anemia gestacional y sus riesgos.

El estudio incluyó a 278 gestantes con anemia durante el embarazo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Criterios de inclusión: gestantes con edad gestacional mayor a 24 semanas. Criterios de exclusión: mujeres con embarazos múltiples. La muestra utilizada para seleccionar a los participantes no fue verificable. Las variables estudiadas fueron: los aspectos sociodemográficos como: edad, IMC, paridad, ingesta de hierro durante el embarazo, y presencia de anemia. La tasa de anemia fue del 4,77%, siendo la anemia leve la más frecuente ⁷.

María-Arango C, Molina C, Mejía C, en su estudio del 2021 titulado Factores asociados con reservas inadecuadas de hierro en mujeres en el primer trimestre del embarazo.

Su objetivo fue observar si existía relación entre los aspectos sociodemográficos, con las reservas inadecuadas de hierro durante el primer trimestre del embarazo. Se trató de un estudio descriptivo, transversal con una población de 664 mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo. Se encontró que la concentración de ferritina sérica era $<30 \mu\text{g/l}$. Variables de estudio: aspectos

demográficos, socioeconómicos, de estilo de vida y dietéticos. Se encontró que la proporción de mujeres embarazadas con reservas insuficientes de hierro fue del 32% y la concentración de ferritina fue de 39,2. Las gestantes que no habían planificado su embarazo tenían 1,1 veces más probabilidades de tener reservas inadecuadas de hierro que las gestantes que si planificaron su embarazo (OR = 2,10; IC 95%: 1,18-3,74). Se encontró asociación entre los factores socioeconómicos con la presencia de niveles de ferritina bajos⁸.

Rincon-Pabon D, Gonzalez-Santamaria J, Urazan-Hernandez Y, en su estudio del 2019 sobre la anemia ferropénica asociado a factores sociodemográficos en Colombia.

Se trató de un estudio descriptivo, transversal con una población de 1.385 mujeres embarazadas de 13 a 49 años. Las variables de estudio fueron: nivel de hemoglobina y ferritina sérica, factores sociodemográficos, factores nutricionales y hábitos nocivos. Se encontró que la anemia por deficiencia de hierro (hemoglobina < 11 g/dl y ferritina < 12 µg/l) se detectó en el 11,0% de las mujeres embarazadas. La anemia se asoció a nivel socioeconómico bajo en un 12.7%, gestantes de zona rural con anemia fue de 12.1%, la presencia de hábitos nocivo durante el embarazo se relacionó a anemia en un 22.2%⁹.

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES

Soto J, en su estudio del 2023 sobre anemia gestacional en el hospital san José.

Realizo un estudio observacional, analítico y retrospectivo de corte transversal que muestra que la tasa de anemia durante el embarazo fue del 78,9%. La mayor tasa de anemia se presenta en los primeros 3 meses de embarazo (38,6%) (p=0,00); y el 54,6% de las gestantes menores de 30 años presentaron anemia (p=0,01). En las gestantes con IMC de 25 a 29,9 la tasa de anemia fue mayor (36,3%) (p=0,29); Al igual que las mujeres que dan a luz a hijos múltiples, se presenta anemia (61,7%) (p=0,03). La asociación de gestantes con periodo intergenesico corto y anemia fue de 56.3% el OR aproximado fue de 5,52. Se encontró asociación entre la anemia y la edad materna, la edad gestacional, la

paridad, el número de exámenes prenatales y el PIG corto. Además, los factores que no tuvieron influencia significativa fueron las comorbilidades como preclampsia y el IMC¹⁰.

Gaspar S, en su estudio del 2023 sobre la relación de anemia y el aspecto clínico y sociodemográfico en gestantes adolescentes del IMAPE, Lima 2015-2019

Hizo un estudio de casos y controles con una población de gestantes de 5408 con 1490 casos y 3918 controles. Los aspectos clínicos fueron paridad, 1er CPN y cantidad de CPN, los aspectos sociodemográficos fueron: edad, procedencia, seguro de salud, relación conyugal y grado de instrucción. El OR fue con intervalo de confianza del 95%. Se obtuvo como resultados que la mediana fue de 18 años, El 1er CPN se dio a las 12 semanas en un 25.2%, un 24.2% tuvo más de 8 CPN. En cuanto a las gestantes primigesta fueron de 83,6% y el 27,6 tuvo anemia. Se encontró una relación importante entre el inicio del CPN tardío, (después de 12 semanas) con la anemia (OR ajustado: 3,48, IC 95%: 2,87-4,22), Se concluye que el inicio tardío de CPN está relacionado a anemia gestacional en las adolescentes¹¹.

López F, Moran R, Medrano K, el 2021 en su estudio sobre anemia en post-cesareadas con y sin COVID-19 en el Hospital Sabogal.

Tuvo como objetivo relacionar la anemia en pacientes pos operadas. Fue un estudio de casos y controles de tipo observacional, transversal y retrospectivo, nivel explicativo, con una población de 358 mujeres en posparto; De ellos, 179 fueron casos y 179 fueron controles. Como resultado, el factor nutricional se asocia a anemia en el puerperio. Además, el antecedente de anemia pre gestacional aumenta la posibilidad de anemia posparto en 5 veces, el consumo de ácido fólico previno la anemia y las complicaciones en el puerperio en 3.4 veces. Se encontró que la anemia durante el embarazo y la ingesta inadecuada de ácido fólico se asocian con complicaciones en el posparto inmediato¹².

Villalva-Luna J, Villena-Prado J, en su estudio del 2021 sobre gestantes anémicas, de edades extremas y su relación con el bajo peso del recién nacido

Fue un estudio de casos y controles retrospectivo, transversal, con una población 312 gestantes constituyendo una relación de 1:2 con 72 casos y 142 controles. Se encontró que las mujeres embarazadas con anemia tenían tasas más altas de parto vaginal y fueron primíparas, así como menor incidencia de abortos espontáneos. No hubo relación entre anemia y gestantes adolescentes con recién nacidos con bajo peso. Mientras que las gestantes añosas con anemia tuvieron un riesgo 6 veces mayor de tener un recién nacido pequeño para la edad gestacional¹³.

Gonzáles Y, en su estudio del 2020 sobre anemia gestacional y el aspecto sociodemográfico, realizó un estudio de casos y controles, analítico, cuantitativo, transversal. La muestra fue de 62 casos y 62 controles. Las variables de estudio fueron: edad, procedencia, número de controles prenatales, IMC, nivel educativo, Y hábitos nocivos.

Como resultado, la edad promedio fue de 26 años, el porcentaje de anemia leve fue de (30,6%), la anemia moderada (14,5%) y la anemia grave (4,8%). Se encontró que existe una asociación entre el origen rural, el nivel educativo, el tabaquismo, CPN insuficiente y el aumento de peso superior a 10 kg con el riesgo para desarrollar anemia durante el embarazo¹⁴.

2.2 BASES TEÓRICAS

ANEMIA

La anemia se caracteriza por presentar una cantidad de glóbulos rojos menor a 4 millones /mm³ en mujeres y menor a 4,5 millones/mm³ en varones o cuando la hemoglobina en la sangre es menor a 12 gr/dl en mujeres y 13,5 gr/dl en varones; y 11 g/dl en mujeres embarazadas¹⁵.

ANEMIA GESTACIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga la anemia durante el embarazo como una condición en la que los niveles de hemoglobina caen por debajo de: 12 g/dl en mujeres en edad reproductiva y por debajo de 11 g/dl en mujeres embarazadas. Si los niveles de hemoglobina disminuyen, esto significa que las reservas de hierro disminuyen y el hematocrito también cae por debajo

del 33%. Se considera a la anemia como un problema de salud pública que urge prevenir y tratar para evitar la morbilidad en las gestantes¹⁶.

EPIDEMIOLOGÍA

A nivel mundial el 30% de las mujeres fértiles padecen anemia. El porcentaje aumenta durante la gestación; Estudios revelan que más del 40% de los embarazos presentan anemia. Los datos de 2019 incluyen las siguientes tasas de anemia durante el embarazo: Asia: 48%, África: 46%, Europa: 24%, América: 19%¹⁷.

La mayoría de la anemia en mujeres en edad reproductiva se debe a depósitos bajos o ausentes de hierro, lo que hace que la anemia ferropénica sea la más frecuente a nivel mundial. La incidencia de la anemia por déficit de hierro en Norte América, Europa y otras regiones con mejores recursos, aunque significativa, es menor que en los estados pobres¹⁸.

MECANISMO FISIOPATOLOGICO DE LA ANEMIA EN LA GESTANTE

El embarazo se caracteriza por cambios notables en la mayoría de los sistemas del cuerpo, esto con el fin de permitir el desarrollo del embarazo, y el sistema hematológico no es una excepción. Durante el embarazo, el volumen plasmático cambia gradualmente, desde la semana 10 hasta la semana 34 de embarazo. Durante el primer trimestre de embarazo se incrementa el volumen plasmático aproximadamente entre un 15 %, alcanzando un 40-50 % entre las 30 y 34 semanas de embarazo. Además, el volumen promedio alcanzado durante estas semanas es de aproximadamente 4700 a 5200 ml, porque durante el embarazo las concentraciones plasmáticas de renina tienden a aumentar y las concentraciones de péptido natriurético auricular disminuyen¹⁹.

El requerimiento total acumulativo para aumentar la masa de glóbulos rojos maternos y la producción/crecimiento fetal de glóbulos rojos fetales es de aproximadamente 500 mg y de 300 a 350 mg. Durante los tres primeros meses, el requerimiento aproximado es de 1 a 2 mg de hierro por día, lo que corresponde a las necesidades normales de una mujer no embarazada. Durante el segundo trimestre, los requerimientos de hierro aumentan a 4 a 5 mg/día debido al aumento de la producción de glóbulos rojos en la madre, así como al aumento

en el número de hematíes y crecimiento del feto y placenta. Durante el tercer trimestre, las necesidades de hierro aumentan a 6 mg/día ²⁰.

CLASIFICACION

La anemia durante el embarazo se puede diagnosticar con un análisis de sangre, hematocrito o hemoglobina, que se puede dividir en:

- Sin anemia: cuando la concentración de hemoglobina es de 11,0 g/dl o superior.
- Anemia leve: valor de hemoglobina entre 10,0 y 10,9 g/dl.
- Anemia moderada: hemoglobina entre 7,0 y 9,9 g/dl.
- Anemia grave: concentración de hb inferior a 7,0 g/dl²⁰.

CAUSA DE ANEMIA EN LA GESTACION

Anemia ferropénica

Representa del 75 al 95% de anemia durante el embarazo, es la más frecuente. Las mujeres embarazadas suelen tener niveles de ferritina insuficiente para permitir el desarrollo adecuado tanto del feto y la placenta. En total se necesitan 850 mg de hierro durante el embarazo. El hierro proporcionado a través de los alimentos no puede proporcionar la cantidad necesaria, por lo que las reservas de hierro se agotarán. Cuando las reservas de hierro son insuficientes se produce anemia ferropénica²¹.

SINTOMAS Y SIGNOS DE ANEMIA

Síntomas comunes: como somnolencia excesiva, debilidad, inapetencia, letargia²².

Piel y mucosas pálidas (síntoma principal).

Transtornos cardiopulmonares: aumento de la frecuencia cardiaca, dificultad para respirar. Esto ocurre cuando los valores de hemoglobina son <5 g/día.

Trastornos digestivos: Lengua lisa, sensible, de color rojo claro o brillante, etc.

Cambios inmunológicos: Defectos en la inmunidad celular.

Síntomas neurológicos: disminución de las funciones de memoria y mala respuesta a estímulos sensoriales²².

FACTORES DE RIESGO PARA ANEMIA GESTACIONAL

Existen factores como la edad, el número de controles prenatales; nivel socioeconómico bajo, dentro de los factores obstétricos tenemos la paridad, patologías preexistentes, como pre eclampsia, hemorragias durante el embarazo, periodo intergenesico corto. Los factores nutricionales, como la pobre ingesta de alimentos ricos en hierro, que pueden influir en el riesgo de anemia. Otras variables asociadas a anemia tenemos tanto el sobrepeso como el poco incremento de peso durante la gestación, y el perímetro braquial²³.

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS OPERACIONALES

Anemia gestacional: son los valores de hemoglobina en el primer y último trimestre de menos de 11 g/dl, y de 10.5 g/dl durante el segundo trimestre²⁴

Edad: Es la expresión en unidades de tiempo los años vividos. Unidad de medida: años

Procedencia: Región geográfica de origen de la gestante. Unidad de medida: Lima, provincia.

Grado de instrucción: Nivel de estudio logrado. Valores: Sin instrucción, primaria, secundaria, superior.

Estado civil: Estado de unión conyugal. Valores: soltera, casada, conviviente²⁵.

Trimestre de gestación: son tres, empieza desde la primera hasta las 12 semanas, luego va de la semana 13 hasta las 26 semanas, el último trimestre empieza en la semana 27 hasta el final de la gestación.

Paridad: cantidad de partos en una mujer fértil. Valores: primigesta, segundigesta, tercigesta, multípara.

Control prenatal: atenciones que el personal médico entrega a una mujer embarazada para descartar patologías que pueden poner en riesgo al binomio madre- niño. Valores: menos de 6, de 6 a más²⁶.

Intervalo genésico (PIG): Es el período desde la fecha del último nacimiento hasta la fecha del inicio del próximo embarazo.

Ganancia de peso: Incremento de peso en kilogramos durante la gestación. Valores: menos de 10 kg, de 10 kg a 15 kg, más de 15 kg.

Índice de masa corporal: Es la proporción entre el peso corporal y la talla en metros. Valores: Bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad²⁷.

Antecedente de anemia gestacional: Historia previa de anemia antes del embarazo. Valores: si, no

Suplementación con hierro: Medicación con tabletas de sulfato ferroso. Valores: Si, no

CAPITULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis General

H1: Los factores individuales están asociados a anemia en gestantes en el CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

H0: Los factores individuales no están asociados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

3.1.2 Hipótesis Especifica 1

H1: Los factores socio-demográficos están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

Ho: Los factores socio-demográficos no están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

Hipótesis Específica 2

H1: Los factores obstétricos están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

Ho: Los factores obstétricos no están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023.

Hipótesis específica 3

H1: Los factores nutricionales están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023

Ho: Los factores nutricionales no están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023.

3.2 Variables del estudio

Variable Dependiente:

- Anemia

Variable Independiente:

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

- Edad
- Procedencia
- Nivel de estudio de
- Oficio
- Situación familiar

FACTORES OBSTÉTRICOS

- Trimestre de embarazo
- Cantidad de CPN
- Periodo intergenesico
- Paridad

FACTORES NUTRICIONALES

- Incremento de peso
- IMC: peso y talla
- Antecedente de anemia
- Administración de sulfato ferroso y ac. fólico

3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable dependiente: Anemia

A. leve : Hb de 10.9 - 10 gr/dl

A. moderada : Hb de 9.9 – 7 gr/dl

A. severa : Hb menos de 7 gr/dl

Variable independiente:

Edad : Adolescentes (14- 17 años)

Adultas (18 – 35 años)

Añosas (36 – 45 años)

Procedencia: Lima , provincia

Estado civil: soltera, casada, conviviente

Paridad: primigesta, segundigesta, tercigesta, multipara

trimestre de embarazo: 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre

número de controles prenatales: menos de 6, de 6 a mas

Periodo intergenesico: más de 5 años, de 5 a 2 años, menos de 2 años

Ganancia de peso: menos de 10 kg, 10 a 15 kg, más de 15 kg

IMC: normal, bajo peso, sobrepeso, obesidad.

Antecedente de anemia: Si, no

Suplementación con sulfato ferroso y ac. Fólico: Si, no

CAPITULO IV: METODOLOGIA

4.1 Diseño Metodológico

El presente estudio se baso en el enfoque cuantitativo, ya que su objetivo fue confirmar teorías mediante el uso de proposiciones generales.

4.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es básica, Según Hernández “La investigación básica, que es la que realiza conocimientos y teorías”²⁴.

Es Observacional: Porque describe una característica o enfermedad de la población sin intervención directa.

Es Analítica: Porque evalúa la relación causa-efecto, a través de análisis estadísticos bivariados.

Es Transversal: la variable es medida en una sola ocasión.

Es Retrospectivo: Se usan datos recogidos por el investigador a través de fuentes como archivos.

4.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Este estudio es de carácter explicativo porque se buscó la relación o asociación entre los factores individuales y anemia en gestantes.

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: constituida por las mujeres embarazadas que reciben atención prenatal en el CMI El Porvenir. durante el periodo del año 2023, siendo en total 662 gestantes que acudieron durante el año 2023 según el área de estadística, de las cuales 167 tenían anemia.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Criterios de inclusión casos

Gestantes atendidas durante el periodo del 2023

Gestantes con menos de 42 semanas

Gestantes comprendidas entre los 14 a 45 años

Gestantes con anemia

Criterios de inclusión controles

Gestantes atendidas durante el periodo 2023

Gestantes con menos de 42 semanas

Gestantes comprendidas entre los 14 a 45 años

Gestantes sin diagnóstico de anemia

Criterios de exclusión casos

Gestantes con anemia previa

Historias clínicas con letra ilegible

Antecedente de enfermedades hematológicas

Gestantes con embarazo múltiple

Criterios de exclusión controles

Gestantes con anemia previa

Gestantes con H.C. incompleta

Gestantes con enfermedades crónicas

Gestantes con gestación múltiple

Muestra: Se tomará el número de gestantes con diagnóstico de anemia que acudieron a CPN durante el 2023, siendo en número de 167, de la cual será 80 casos y 80 controles

Muestreo: Se realizará mediante la técnica de muestreo aleatorio simple

4.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnica: Se utilizará análisis documental, revisión de registros médicos y recopilación de datos.

La herramienta que se utilizará será una hoja de recolección de datos donde figure los factores individuales que pueden influir en la anemia materna.

4.4 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los datos recolectados se tabularán y evaluarán con el software estadístico Epidat 4.2, donde se ingresará la lista de historia clínicas, a la vez que estos datos se graficarán en tablas y cuadros estadísticos.

4.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se registrará a los principios de bioética de Beauchamp y Childress:

Respeto a la autonomía: Se respetará la libertad de elección de la persona, el cual se pone en práctica a través del consentimiento informado, en el presente estudio no se utilizará consentimiento informado ya que la información se obtendrá de las historias clínicas.

Beneficencia: en beneficio del enfermo, en nuestro caso el presente estudio servirá para tener información actualizada sobre el porcentaje de anemia gestacional en el CMI El Porvenir durante el año 2023.

No maleficencia: El presente trabajo no causará daño intencionalmente.

Justicia: Distribución de manera equitativa los recursos sanitarios entre todos los individuos de la sociedad.

Confidencialidad: Los datos extraídos de las fichas se digitalarán en una computadora personal de uso exclusivo del investigador.

CAPITULO V: ADMINISTRACION DE LA INVESTIGACION

5.1 PRESUPUESTO

A. PERSONAL	UNIDADES	MONTO
Asesor Metodológico	1	S/.1200
Asesor Estadístico	1	S/.1200
Asesor Especialista	1	S/.1200
SUBTOTAL		S/.3600
B. BIENES		
Escritorio	1	S/. 300
Computadora	1	S/. 1500
Impresora	1	S/. 700
Tinta de impresora	4	S/. 40
Hojas Bond	300	S/. 60
SUBTOTAL		S/. 2600
C. SERVICIOS		
Luz	6 meses	S/. 600
Internet	6 meses	S/. 600
Digitación	6 meses	S/. 300
Anillados	5	S/. 50
Empastados	5	S/. 100
Telefono	6 meses	S/. 200
Pasajes		S/. 200
Otros		S/. 200
Subtotal		S/. 1650
TOTAL		S/. 7850

5.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Titulo del trabajo de investigacion	x					
Elaboracion del planteamiento, Objetivos y Justificación	x					
Redacción del Marco Teórico	x					
Redacción de los instrumentos de investigación	x					
Redacción de los recursos, cronogramas, fuentes de Investigación y anexos	x					
Entrega del proyecto de tesis		x	x			
Aprobación del proyecto de tesis por el comité de ética			x			
Aplicación de los instrumentos y resultados				x		
Elaboración de la discusión, recomendaciones, conclusión				x		
Presentación del informe final de investigación					x	
Aprobación del informe final de tesis					x	x
Sustentación de la tesis						x
Emisión del título de culminación de carrera						x

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Metas mundiales de nutrición 2025: documento normativo sobre anemia [Internet]. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.4>
2. Espinola-Sánchez M, Sanca-Valeriano S, Ormeño-Julca A. Factores sociales y demográficos asociados a la anemia en mujeres embarazada en Perú. Revista chilena de Obstetricia y Ginecología 2021; 86(2): 192 – 201
3. Murillo-Zavala A, Baque-Parrales G, Chancay-Sabando C. Prevalencia de anemia en el embarazo tipos y consecuencias. Revista científica Dominio de las ciencias., ISSN: 2477-8818 Vol. 7, núm. 3, Julio-Septiembre 2021, pp. 549-562
4. Bernárdez F. El ciclo perverso de la anemia en la gestación. Revista Mexicana de Medicina Transfusional. Vol. 14, Supl. 1, pp s96-s98 . Mayo - Agosto, 2022.
5. Rincón-Pabón D, Urazán-Hernández Y, Gonzalez-Santamaria J. Prevalencia y factores sociodemográficos asociados a anemia ferropénica en mujeres gestantes de Colombia (análisis secundario de la ENSIN 2010). Nutr Hosp. 2019 Mar 7;36(1):87-95. Spanish. doi: 10.20960/nh.1895. PMID: 30836760.
6. Garbay Y, Batista Y, Alvarez J, Factores de riesgo de la anemia durante el embarazo. Revista Electrónica Medimay 2023 Jul-Sep; 30(3).
7. Lardito F, Maldonado A, Marcenal Y, et al. Anemia y embarazo en el Centro Hospitalario Pereira Rossell 2021. Ciclo de metodología Científica II- 2022- Facultad de Medicina- Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
8. María-Arango C, Molina C, Mejía C, Factores asociados con reservas inadecuadas de hierro en mujeres en el primer trimestre del embarazo. Rev Chil Nutr 2021; 48(4): 595-608.
9. Rincon-Pabon D, Gonzalez-Santamaria J, Urazan-Hernandez Y, Prevalencia y factores sociodemográficos asociados a anemia ferropénica

- en mujeres gestantes de Colombia. Nutr Hosp 2019;36(1):87-95 DOI: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.01895>
10. Navarro I, Factores de riesgo de anemia gestacional en pacientes atendidas en el CMI Juan Pablo II 2022(Internet). Universidad San Juan Bautista,2024 repositorio
 11. Soto J. Factores asociados a anemia en gestantes hospitalizadas del Hospital San José. Revista Peruana de Investigacion Materno Perinatal. 2023; 9(2):31-3.
 12. Gaspar S., Factores clínicos y sociodemográficos asociados a la anemia en las adolescentes embarazadas-Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2015-2019 (Internet).UNMSM. Repositorio Institucional 2023.
 13. Villalva-Luna J, Villena- Prado J. Relación entre gestantes con anemia en edad materna de riesgo y bajo peso al nacer en un hospital de la seguridad social del Perú. Revista de la Facultad de Medicina Humana. Enero 2021; 21(1):101-107.
 14. Gonzáles Y, Factores de riesgo asociados a anemia gestacional en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital de Apoyo II - 2 de Sullana, 2019. (Internet).Universidad Cesar Vallejo; 2020.
 15. Arredondo-Nontol M, Arredondo-Nontol R. Necesidad de optimizar la definición de anemia en la gestación de la organización mundial de la salud en el ámbito de los cambios fisiológicos de la gestante a nivel del mar y en altura. Revista médica de Trujillo. 2020;15(2):55-6 Carta al Editor. DOI:<http://dx.doi.org/10.17268/rmt.2020.v15i02.02>
 16. Arango C, Molina C, Mejía C. Factores asociados con inadecuados depósitos de hierro en mujeres en primer trimestre de gestación. Revista Chilena de Nutrición 2021; 48(4): 595-608. Artículo Original
 17. Díaz-Granda R, Díaz-Granda L. Anemia gestacional del tercer trimestre: frecuencia y gravedad según la edad materna. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2020;58(4):428-436.
 18. López F, Moran R, Medrano K. Factores asociados a anemia en post-cesareadas con y sin COVID-19 en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Anales de la Facultad de medicina. 2021;82(4):282-9

19. Bermudez K, Córdoba-Vives S, Leal-Mateos M. Deficiencia de hierro y anemia en tercer trimestre. Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. REVCOG 2023; 27(2):37-45.
20. Correa I, Montoya S, Villada O. Prevalencia de anemia en la gestación y su relación con el peso al nacer Revista Brasileña de Salud Materno Infantil. 2023. Pag 1-10 <https://doi.org/10.1590/1806-9304202300000333-enRev>.
21. Pérez A. Prevalencia y evolución de la anemia en embarazadas del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Revista de investigación clínica y biomédica Montevideo, Uruguay. Pag 1-6.
22. Gaspar S, Luna A, Carcelén C. Anemia en madres adolescentes y su relación con el control prenatal Revista Cubana de Pediatría vol.94 no.3. Revista Cubana de Pediatría. 2022;94(2):e1931.
23. Munares-García O, Gómez-Guizado G. Adherencia al consumo de suplementos de hierro y factores asociados en gestantes peruanas. Revista Cubana de Salud Pública. 2021;47(4):e1026 pag 1 – 17.
24. Moreira A, Viana A, Meira A, Pereira D. Suplementación oral de hierro durante el embarazo: recomendaciones actuales y medicina basada en evidencia. Rev Bras Ginecol Obstet 2021;43(10):782–788.
25. Shamah-Levy T, Mejía-Rodríguez F, García-Guerra A, Vizuet-Vega I, Gómez-Humarán I, Comportamiento y factores asociados con la anemia en mujeres mexicanas en edad fértil. Ensanut 2018-19 salud pública de México / vol. 62, no. 6, noviembre-diciembre de 2020 pag 767-776
26. Gonzales G, Olavegoya P. Fisiopatología de la anemia durante el embarazo: ¿anemia o hemodilución? Rev Peru Ginecol Obstet. 2019;65(4) 489- 502.
27. Alegría R, Gonzales C, Huachín F. El tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo y el puerperio. Rev Peru Ginecol Obstet. 2019;65(4) 503-509.
28. Gonzales-Medina C, Arango-Ochante P. Resultados perinatales de la anemia en la gestación. Rev Peru Ginecol Obstet. 2019;65(4) 519-526.
29. Pérez M, Peralta M, Villalba Y, Vanegas S, Rivera J. Caracterización de la población con anemia en el embarazo y su asociación con la

- morbimortalidad perinatal. Rev. Méd. Risaralda 2019; 25 (1) pag 33-39a. Antioquia-Colombia.
30. Taipe-Ruiz B, Troncoso-Corzo L. Anemia en el primer control de gestantes en un centro de salud de Lima, Perú y su relación con el estado nutricional pregestacional. Revista de la facultad de medicina humana de la Universidad de San Martín de Porres. Horiz Med (Lima) 2019; 19(2): 6-11.
31. Santana M, Da Costa A, Soares C, Santos A, Barbosa D. influência da anemia em gestantes sobre o peso ao nascer: um estudo da coorte nisami Revista Baiana de Saúde Pública. 43, n. 3, p. 581-598 jul./set. 2019.
32. Alvarado C, Yanac- Avila R, Marron-Veria E, Málaga-Zenteno J, Adamkiewicz T. Avances en el diagnóstico y tratamiento de deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Anales de Fac med. 2022;83(1):65-9.
33. Bonilla-Untiveros B, Rivero B. Eficacia y seguridad del hierro polimaltosado para gestantes con anemia: revisión sistemática y metaanálisis. Revista de Investigación (de la Universidad Norbert Wiener). Rev. Inv. UNW. 2022; 11(1): r0001 doi: 10.37768/unw.rinv.11.01.r0001.
34. Otamendi I, Zalba M, Goicoechea A, Galbete A, Prevalencia de anemia en población gestante. Med Clin (Barc). 25 de marzo de 2022; 158 (6): 270-273.
35. Hertrampf E, Olivares M, Letelier A, Castillo C. Situación de la nutrición de hierro en la embarazada adolescente al inicio de la gestación [Iron nutritional status in pregnant adolescents at the beginning of gestation]. Rev Med Chil. 1994 Dec;122(12):1372-7. Spanish. PMID: 7659911.
36. Norma técnica – manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y púerperas Minsa 2017

ANEXO 1

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

ALUMNA: SANDRA ELIZABETH SIGUAS GODOY

ASESOR: DR. ROY ANGULO REYES

LOCAL: CHORRILLOS

TEMA: FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS A ANEMIA EN GESTANTES DEL CMI EL PORVENIR DURANTE EL PERIODO DEL 2023

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES INDIVIDUALES			
INDICADORES	ITEMS	NIVEL DE MEDICION	INSTRUMENTO
<u>FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS:</u>			Ficha de recolección de datos
Edad	14–19 / 20-34 / 35-45	Intervalo	
Grado de instrucción	Analfabeta/Primaria/Secundaria/Superior	Ordinal	
Procedencia	Lima/Provincia	Nominal	
Estado civil	Casada/conviviente/soltera	Nominal	

<u>FACTORES GINECOOBSTETRICOS</u>			
Número de controles prenatales	Menos de 6 CPN/6 a mas controles	Ordinal	
Trimestre de embarazo	I trimestre/II trimestre/III trimestre	Ordinal	
Paridad	Primigesta / Segundigesta / Tercigesta / Multipara	Ordinal	
Periodo Intergenesico	Menos de 2 años/ 2 a 5 años/mas de 5 años	Ordinal	
VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES INDIVIDUALES			
INDICADORES	ITEMS	NIVEL DE MEDICION	INSTRUMENTO
			Ficha de recolección de datos
<u>FACTORES NUTRICIONALES</u>			
Ganancia de peso	Menos de 10 kg/ 10 - 15 kg/ mas de 15 Kg	Ordinal	
IMC: peso y talla	Bajo peso/Peso normal/Sobrepeso/Obesidad	Ordinal	
Antecedente de anemia	SI/NO	Nominal	
Suplementacion con Hierro	SI/NO	Nominal	
VARIABLE DEPENDIENTE: Anemia			
A. Leve	Hemoglobina: 10 - 10.9 g/dl	Ordinal	Ficha de recolección de datos
A. Moderada	Hemoglobina:		
A. Severa	Hemoglobina:		

ANEXOS 2

	UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUA BAUTISTA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA
---	--

Título: FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS A ANEMIA EN GESTANTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL EL PORVENIR DURANTE EL PERIODO DEL 2023

Autor: Sandra Elizabeth Siguas Godoy

Fecha: 08/04/2024

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS (INSTRUMENTO)

Ficha de Recolección de Datos N° -- FICHA: ----- N° H.C: -----

A. **ANEMIA:** Con Anemia / Sin anemia

B. FACTORES INDIVIDUALES

1. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS

Edad: 14- 19 años / 20-34 años / 35-45 años

Grado de instrucción: Sin instrucción /Primaria / Secundaria /Superior

Procedencia: Lima / Provincia

Estado Civil: Soltera / Casada / Conviviente

2. FACTORES OBSTETRICOS

Número de control prenatal: menos de 6 CPN / 6 a mas CPN

Paridad: Primigesta / Segundigesta / Tercigesta / Multigesta

Período Intergenésico: Corto/ largo

Trimestre de Embarazo: 1er trimestre/ 2do trimestre/ 3er trimestre

3. FACTORES NUTRICIONALES

Ganancia de peso: Menos de 10 kg / 10 a 15 kg / mas de 15 kg

IMC: Bajo peso / Normal / Sobrepeso / Obesidad

Administración de Sulfato ferroso: SI / NO

Antecedente de anemia: SI / NO

ANEXO 3

MATRIZ DE CONSISTENCIA

ALUMNA: SANDRA ELIZABETH SIGUAS GODOY

ASESOR: DR. ROY ANGULO REYES

LOCAL: CHORRILLOS

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES E INDICADORES
General: PG: ¿Cuáles son los factores individuales relacionados a anemia en gestantes del Centro Materno Infantil El Porvenir, en el periodo del 2023? Específicos: PE 1: ¿Cuáles son los factores sociodemográficos relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir en el periodo del 2023? PE 2: ¿Cuáles son los factores obstétricos relacionados a anemia del CMI El Porvenir en el periodo 2023?	General: OG: Determinar cuáles son los factores individuales relacionados a anemia en gestantes del Centro Materno Infantil El Porvenir durante el periodo 2023 Específicos: OE 1: Establecer los factores demográficos a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023 OE 2: Identificar los factores obstétricos relacionados a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo 2023	General: HG: Los factores individuales están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo del 2023 Específicos: HE1: Los factores demográficos están relacionados a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo 2023 HE 2: Los factores gineco obstétricos	Variable Independiente Factores demográficos - Edad - Grado de Instrucción - Procedencia - Estado Civil Factores obstétricos - Trimestre de Embarazo - Paridad - Número de controles prenatales - Periodo intergenesico Factores nutricionales - Ganancia de peso - IMC - Antecedente de anemia

PE 3: ¿Cuáles son los factores nutricionales relacionados a anemia del CMI El Porvenir en el periodo 2023?	OE 3: Establecer los factores nutricionales relacionados a anemia en las gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo 2023	están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo 2023 HE 3: Los factores nutricionales están relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir durante el periodo 2023	- Administración de sulfato ferroso Variable Dependiente - Anemia
--	---	--	--

TEMA: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES INDIVIDUALES RELACIONADOS A ANEMIA EN GESTANTES DEL CENTRO MATERNO INFANTIL EL PORVENIR EN EL PERIODO DEL 2023?

Diseño Metodológico	Población y Muestra	Técnica e Instrumentos
-Nivel: Básico Explicativo -Tipo de investigación: Observacional Transversal Retrospectivo Analítico (casos y controles)	Población de gestantes que acuden a CPN al CMI El Porvenir durante el periodo del 2023: 662 de las cuales 167 son gestantes con anemia N= : 160 = 80 casos y 80 controles Criterios de Inclusión: Gestantes atendidas en el CMI El Porvenir durante el periodo 2023 Gestantes con menos de 42 semanas Criterios de exclusión:	Técnica: Revisión documental (Historias clínicas) Instrumento: Ficha de recolección de datos Software estadístico: EpiDat 4.2

	Historias clínicas con letra ilegible Pacientes con anemia previa Antecedentes de enfermedades hematológicas Gestantes con embarazo múltiple N= 160 (Población Objetivo) Tamaño de muestra: 80 casos y 80 controles Muestreo: muestreo aleatorio simple	
--	---	--

Asesor

Estadístico

Anexo 3 Validación por Experto

Informe de Opinión de Experto

1. Datos Generales:

1.1. **Apellidos y nombres del experto:** Dr. Roy Martín Angulo Reyes

1.2. **Cargo e institución donde labora:** Docente UPSJB

1.3. **Tipo de experto:** Metodológico ☒ Especialista ☐ Estadístico ☐

1.4. **Nombre del Instrumento:**

1.5. **Autor del instrumento:**

2. Aspecto de Validación:

Indicadores	Criterios	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
Claridad	Está formulado con un lenguaje claro.					
Objetividad	No presenta sesgo ni induce respuestas					
Actualidad	Esta de acuerdo con los avances la teoría sobre factores de riesgo asociados a fracturas de caderas en adultos mayores.					
Organización	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					
Suficiencia	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					
Intencionalidad	Adecuado para establecer Factores de riesgo asociados a fracturas de caderas en adultos mayores.					
Consistencia	Basados en aspectos teóricos y científicos.					
Coherencia	Entre los índices e indicadores.					
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación analítica.					

3. Opinión de aplicabilidad:

..... (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

4. Promedio de Valoración:

Lugar y Fecha: Lima, abril del 2024

.....

Firma del Experto

DNI N°.....

Teléfono.....

Nota: Es necesario realizar una prueba estadística de validación de instrumento.

Anexo 4 Validación por Experto

Informe de Opinión de Experto

1. Datos Generales:

1.1 Apellidos y nombres del experto: Mg. Elsi Bazán Rodríguez

1.2 Cargo e institución donde labora: Docente UPSJB

1.3 Tipo de experto: Metodológico ☐ Especialista ☐ Estadístico ☒

1.4 Nombre del Instrumento: Factores individuales relacionados a anemia en gestantes del CMI El Porvenir en el periodo del 2023

1.5 Autor del instrumento: Sigvas Godoy Sandra Elizabeth

2. Aspecto de Validación:

Indicadores	Criterios	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
Claridad	Está formulado con un lenguaje claro.					
Objetividad	No presenta sesgo ni induce respuestas					
Actualidad	Esta de acuerdo con los avances la teoría sobre factores de riesgo asociados a fracturas de caderas en adultos mayores.					
Organización	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					
Suficiencia	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					
Intencionalidad	Adecuado para establecer Factores de riesgo asociados a fracturas de caderas en adultos mayores.					
Consistencia	Basados en aspectos teóricos y científicos.					
Coherencia	Entre los índices e indicadores.					
Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación analítica.					

3. Opinión de aplicabilidad:

..... (Comentario del juez experto respecto al instrumento)

4. Promedio de Valoración:

Lugar y Fecha: Lima, abril del 2024

.....

Firma del Experto

DNI N°

Teléfono.....

Nota: Es necesario realizar una prueba estadística de validación de instrumento.